

Abdome agudo · raciocínio e prioridades

Abdome agudo exige decidir rápido: há peritonite ou instabilidade que imponha cirurgia? TC ajuda no estável; no instável com abdome cirúrgico, vá ao centro cirúrgico.

Exame dirigido

Dica - Exame dirigido

Localização da dor, irradiação, febre, parada seletiva de eliminações, hérnia encarcerada e toque retal fazem parte do exame mínimo de prova.

Separe quem opera agora, quem investiga com imagem e quem tem causa clínica (cetoacidose, pneumonia basal, IAM).



Checklist da porta

- ABC, acesso, analgésico (não 'mascara' diagnóstico moderno — alivie dor)
- Labs: hemograma, PCR, lactato, função renal, ;"Ö,4r VÒ Đulher fértil
- Imagem: Rx se perfuração/obstrução; TC contrastada no estável duvidoso
- Cirurgia cedo se defesa, ar livre, isquemia ou hérnia estrangulada

Dor por quadrante (atalhos)

Local | Pensar em

QSD | Colecistite, úlcera, pneumonia

QSE | Pancreatite, úlcera, baço

FIE | Diverticulite

FID | Apendicite, anexial, ileíte

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Toda mulher em idade fértil com dor abdominal: ;"Ö,4r çFW2 FR –Ö vVÒ –öæ—| çFRö6— urgia eletiva.
Idoso: apendicite e isquemia apresentam-se atípicas — limiar baixo para TC.

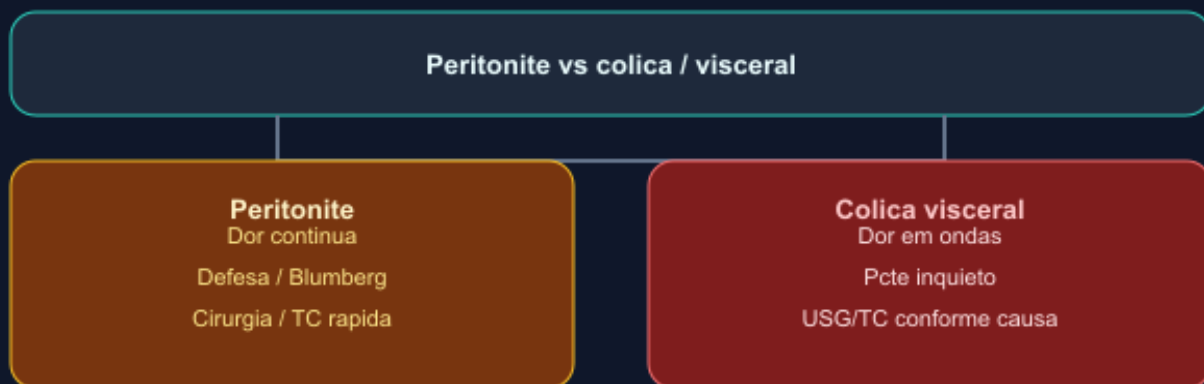
Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Abdome agudo: separar peritonite (cirúrgico) de cólica/obstrutivo visceral muda imagem, timing e indicação operatória.

Peritonite = defesa/rigidez e pouca mobilidade !' rumo à cirurgia. Cólica = inquietação, intervalos !' cálculo, obstrução inicial, isquemia precoce.

Abdome agudo - abordagem



Contraste clínico

| Peritonite | Cólica / visceral

Dor | Contínua, piora com movimento | Em cólicas, com intervalos

Postura | Imóvel, joelhos fletidos | Inquieto, anda/rola

Exame | Defesa, rigidez, descompressão+ | Pode ser pobre entre crises

Exemplos | Perfuração, apendicite avançada | Litiase ureteral, obstrução inicial, biliar

Abordagem prática

- ABC, volume, jejum, analgesia (não 'mascara' indicação se reavaliar)
- Lab: hemograma, PCR, ;"Ô,,4r VÒ ðulher, lipase, função renal, lactato se grave
- Imagem dirigida: USG (biliar/gineco), TC (maioria dos adultos dúbios), Rx se perfuração/obstrução
- Cirurgião cedo se peritonite, instabilidade ou ar livre

Idoso e imunossuprimido

Atencao - Idoso e imunossuprimido

Sinais peritoneais podem ser pobres — limiar baixo para TC e avaliação cirúrgica.

Mulher em idade fértil

Lembre - Mulher em idade fértil

;"Ô,,4r 6V× &P. Diferencial: ectópica, TORÇÃO de anexos, DIP — USG pélvico.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1